

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação 24/03/2023	Próxima Revisão 24/03/2025	Versão nº 04	Rotina nº 16	Página 01 a 05
Nome do Procedimento: Retirada de Pontos				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde				
Gerência: Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerências de Distritos Sanitários, Gerência de Serviços Especiais				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem				
Objetivo: Definir as rotinas para retirada de pontos cirúrgicos				
Recursos necessários: ✓ 01 Tesoura Íris estéril; ✓ 01 Pinça Kelly ou anatômica ou dente de rato ou <i>Kocher</i> estéril; ✓ Gaze estéril; ✓ Luvas de procedimento; ✓ Soro Fisiológico 0,9%; ✓ Clorexidina aquosa a 2%; ✓ Foco de luz (se necessário); ✓ Fita adesiva cirúrgica (se necessário para cobrir a ferida após a retirada dos pontos). ✓ Luva estéril (na ausência de pinça); ✓ Lâmina de bisturi (na ausência de tesoura esterilizada, sendo mais seguro usá-la com o cabo de bisturi).				

CONCEITO

A retirada de pontos consiste na remoção dos fios cirúrgicos com técnica asséptica, oferece uma limpeza da incisão cirúrgica, favorece a drenagem de exsudato, auxilia na cicatrização cirúrgica, previne infecções e rejeição e permite a equipe avaliar a coaptação das bordas, recuperação cirúrgica, sinais de infecção e evolução geral do sítio cirúrgico (ZOGBI *et al*, 2021).

A remoção dos pontos ocorrerá após o tempo suficiente para assegurar o fechamento inicial da ferida, com força de tensão adequada para manter as bordas unidas, justapostas e/ou coaptadas. O prazo para a remoção é variável, com média geral entre 7 e 10 dias (POTTER *et al.*, 2018).

DESCRIÇÃO

1. Pré – execução

- ✓ Observar prescrição médica para a retirada de pontos;
- ✓ Na ausência de prescrição médica, cabe ao enfermeiro da Unidade avaliar a ferida operatória e prescrever, se necessário, a retirada de pontos, conforme figura 01.

Figura 01 – Relação entre o tempo de retirada dos pontos cirúrgicos e a região anatômica

TEMPO	Dias	PARA RETIRADA DA SUTURA
	7 a 10	▶ Couro cabeludo
	3 a 4	▶ Pálpebra e lábio
	3 a 5	▶ Nariz e supercílio
	10 a 14	▶ Orelha
	8 a 10	▶ Tronco (face anterior)
	12 a 14	▶ Dorso e extremidades
	10 a 14	▶ Mão, pé e sola
	+ 2 a 3	▶ Adicionar para áreas de articulação

Fonte: ZOGBI *et al*, 2021.

Importante: O prazo para a retirada dos pontos é variável, e está ligado diretamente a condição clínica do usuário, estado geral de saúde, manuseio e mobilização local, atrito e condições de assepsia e limpeza, não devendo ser seguida de modo rigoroso, sendo a avaliação do profissional indispensável.

2. Execução

- ✓ Lavar as mãos;
- ✓ Preparar o material;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Identificar-se;
- ✓ Orientar o usuário e/ou acompanhante quanto ao procedimento;
- ✓ Colocar o material a ser usado próximo do usuário em superfície fixa;
- ✓ Aproximar o recipiente para o descarte dos resíduos (lixeiro infectante), em posição que não cruze material sujo sobre o limpo;
- ✓ Colocar o usuário em posição confortável, expondo apenas o local da incisão;
- ✓ Retirar o curativo, quando houver, usando técnica de curativo simples (usar luvas);
- ✓ Verificar as condições de cicatrização, aspecto da pele, captação das bordas, sinais de infecção ou sinais de drenagem de secreção.

2.1 Avaliação da Pele e da Sutura

A avaliação minuciosa da pele e da sutura (ferida operatória ou lesão) é de suma importância para certificar-se que há condições para a remoção completa ou parcial dos pontos.

Os pontos NÃO devem ser removidos ou removidos parcialmente nas condições abaixo:

Quadro 01 – Condições da pele e modo de remoção

Condição da pele/ferida	Remoção
Sinais de coágulo volumoso entre as bordas ou no ponto de inserção do fio	• Não remover o ponto; • Realizar curativo compressivo; e • Avaliar com equipe médica.
Presença de coágulo em ponto específico	• Não remover o ponto no local do coágulo, mantendo um ponto em cada extremidade do local do coágulo; • Realizar curativo compressivo; e • Avaliar com equipe médica.
Exsudato seroso ou purulento em ponto específico	• Remover apenas nas porções sem drenagem de exsudato; • Avaliar com equipe médica.
Exsudato seroso ou purulento em toda a extensão da ferida	• Remover pontos alternados; • Mantendo os pontos das extremidades; • Avaliar com equipe médica.
Bordas afastadas em ponto específico	• Não remover o ponto no local de afastamento, mantendo um ponto em cada extremidade da área afastada.
Múltiplos pontos com borda afastada	• Não remover o ponto; e • Reavaliar com equipe médica.
Deiscência de sutura	• Remover os pontos que estiverem soltos; e • Reavaliar com equipe médica.

Fonte: SES/Joinville, 2023.

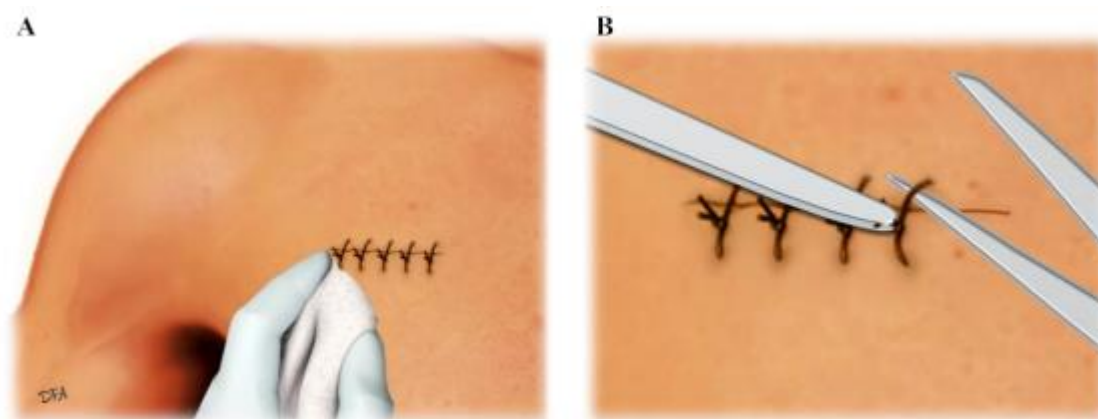
2.2 Após a Avaliação

- ✓ Colocar o pacote de retirada de pontos sobre o carrinho ou bandeja;
- ✓ Dispor as pinças em um lado, em cima e na borda do campo esterilizado, com auxílio da pinça;
- ✓ Realizar a limpeza da incisão com clorexidina aquosa a 2%, com ajuda da pinça e secar;
- ✓ Preparar a tesoura ou bisturi;
- ✓ Colocar uma gaze próxima à incisão para depositar os fios retirados;
- ✓ Segurar uma das pontas do ponto com a pinça anatômica e cortar uma das extremidades do laço sob o nó, o mais próximo possível da pele e puxar o ponto, retirando-o;
- ✓ Realizar a retirada alternando os pontos, e sob qualquer sinal de complicação (deiscência de sutura) seguir orientação da nota abaixo;
- ✓ Proceder da mesma maneira para os demais pontos;
- ✓ Em sutura contínua, corte o fio em uma das extremidades e retire-o puxando pelo lado oposto;
- ✓ Desprezar a gaze;

- ✓ Observar se todos os pontos saíram por inteiro;
- ✓ Limpar a incisão com solução fisiológica a 0,9% e cobrir a área somente se houver presença de exsudato, área desepitelizada ou quando a área da remoção dos pontos estiver sob atrito;
- ✓ Na ausência de pacote com pinças e tesouras específicas, utilizar lâmina de bisturi estéril com cabo, um par de luvas estéreis e gaze estéril, utilizando o pacote da gaze ou luva estéril como apoio para os materiais esterilizados.

Nota: Durante a retirada dos pontos, se for notado algum sinal de deiscência, alguns pontos de ancoragem podem ser deixados, além de reforço de adesivo, e se não houver sinais de complicações como citado no quadro 1, reavaliar em 2-3 dias para completar a retirada dos outros pontos.

Figura 02 – Retirada correta dos pontos



Fonte: ZOGBI *et al*, 2021

2.3 Pós – Execução

- ✓ Acondicionar/destinar material contaminado para limpeza e desinfecção;
- ✓ Desprezar o material descartável utilizado em lixeira adequada e de acordo com o gerenciamento dos resíduos;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Realizar evolução no Prontuário Eletrônico (SIG-Saúde Tech).

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Procedimentos**. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Primária, nº 30. Brasília – DF: 2011.
2. BRUNNER e SULDDARTH. **Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgico**. Editora Guanabara / Koogan. 10ª Edição. Rio de Janeiro – RJ: 2018.
3. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Cofen). **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986**. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Brasília – DF: 1986.
4. POTTER, Patrícia Ann; PERRY, Anne Griffin; [tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento, et al]. Fundamentos de Enfermagem. Editora Elsevier. 9ª edição. Rio de Janeiro – RJ: 2018.
5. PRADO, Marta Lenise do; GELBCKE, Francine Lima. **Fundamentos para o cuidado profissional de enfermagem**. Editora Progressiva. 3ª edição. Florianópolis – SC: 2013. 548p.
6. Hospital Universitário Pedro Ernesto. Procedimento Operacional Padrão de Enfermagem. **Retirada de pontos cirúrgicos**. Rio de Janeiro – RJ: 2014.
7. PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria da Saúde. Coordenação da Atenção Básica. **Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde**. 2ª Edição. São Paulo – SP: 2014. 162 p.
8. ZOGBI, Luciano; RIGATTI, Gabriel; AUDINO, Daniel F. **Sutura Cirúrgica**. Vittalle – Revista de Ciências da Saúde v. 33, n. 1 (2021) 29-44.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Manuelle Hölscher Belz	Flávia Favaretto Gabriela Cristina da Silva Brandão	Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardozo Pacheco

Disponível pelo Endereço Eletrônico

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.046727-0

Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	Maio/2016	Comissão de Enfermeiros da Atenção Básica	
03	Jan/2020	Renata Andrade Teixeira Heil	
04	Mar/2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão das Figuras 01 e 02; • Inclusão do texto de avaliação da pele e sutura; • Inclusão do Quadro 01; • Alteração/atualização da descrição técnica.

